

[CQI] 외래 원스톱 시스템 정착 및 활성화 활동

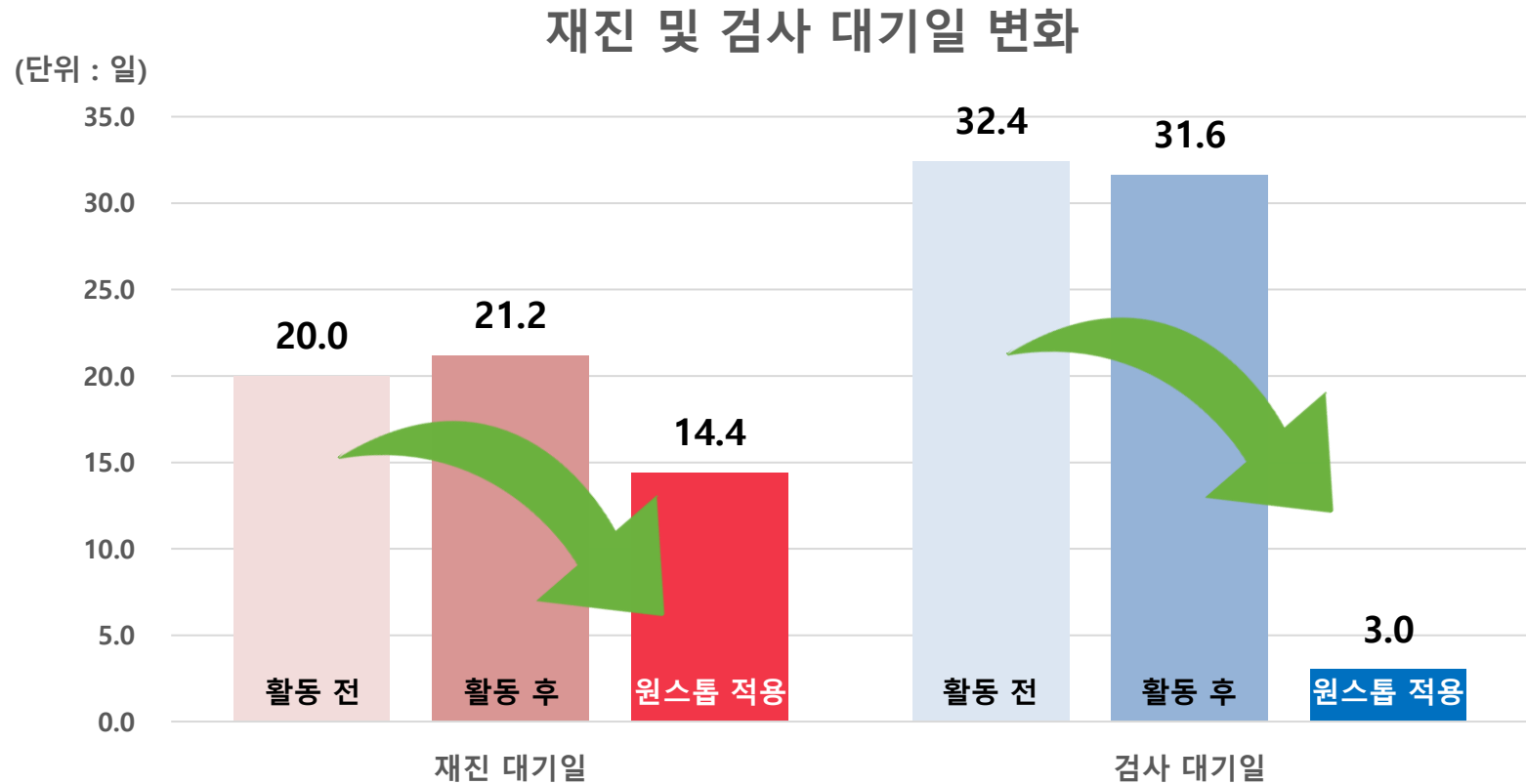
팀명 : 원샷원킬



1. 2024년도 Top Down QI 활동을 통해 치료의 적시성을 높이고, 의료 자원을 효율적으로 사용하기 위해 '원스톱' 시스템을 개발, 적용하였다.
2. 활동 결과, 원스톱 시스템을 적용할 경우 대기 일수가 일반 환자에 비해 크게 감소하여 직원, 환자 모두 긍정적인 반응을 보였다.
3. 이에 다양한 장점을 확대하고자 시스템의 정착 및 활성화를 위해 추가 활동이 필요함을 제안하였다.
4. 시스템을 운영할 전담부서 및 인력 확대, CAPA 확보 등 다양한 지원을 통해 원스톱 시스템의 활성화를 이루고, 의료의 질을 향상시키고자 한다.

현 수준

1. 전년도 QI활동 전후 핵심지표 변화

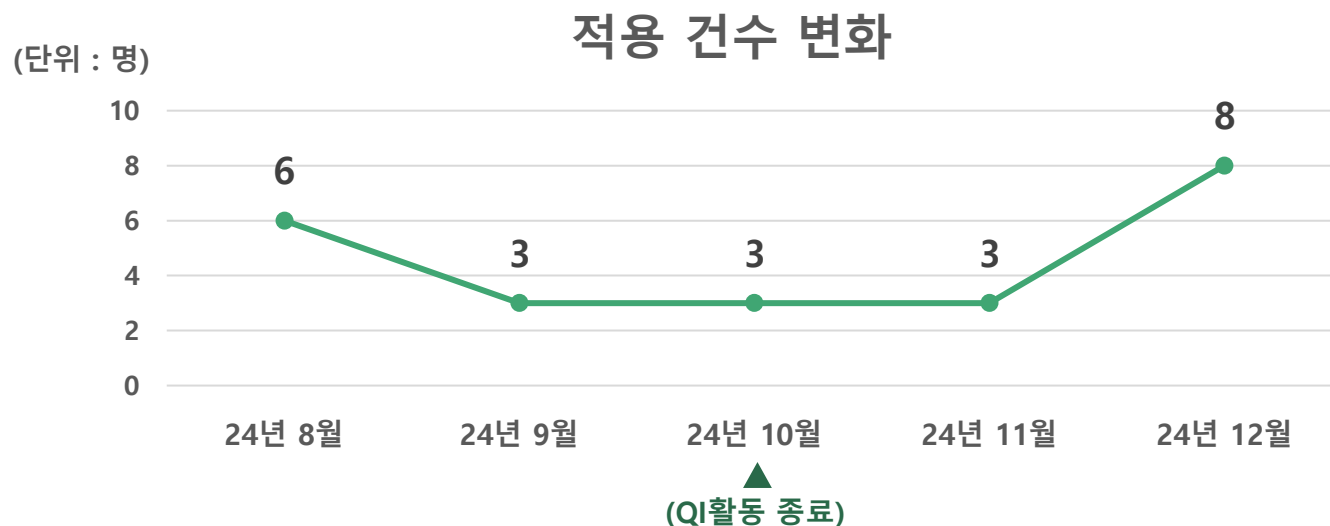


*QI활동 전: 2024.1.1~2024.2.29, 신환 및 초진
 *QI활동 후: 2024.8.16~2024.10.15, 신환 및 초진
 *원스톱 적용: 2024.8.1~2024.10.31, 원스톱 적용 대상자

2. 활동 종료 후 원스톱 시스템 현황

- 2024년도 Top Down QI 활동 시작일로부터 **2024년 12월 31일까지의 누적**
- **실질적인 효과 평가**를 위해서는 **확대 적용 필요**

트랙	누적 대상자	대기일*	비고
유방암 첫 진단	23명	3.1일	2024.8.1~



*대기일 : 진료일로부터 예약제검사, 수술, 입원, 재진 중 1가지를 달성하기까지 소요된 날짜

3. 타원 사례

병원 사례	명칭	비고
A 병원	암 진료 빠른 예약 서비스	진료부터 검사까지 원스톱 진료 진행
B 병원	암 환자 Fast track	- 신규 암 진단 환자 대상 - 전용 예약 CAPA 통해 빠른 치료 제공
C 병원	초진 환자 Fast track	- 진료의 요청 시(주로 수술 대상자) - 별도의 예약 CAPA 통해 진료, 검사 등 진행
D 병원	암 치료 원스톱 Fast track	3일 이내 검사 및 진단 7일 이내 수술 및 시술 제공
E 병원	암환자 Fast Track One-stop 서비스	- 진료 당일 검사 7일 이내 판독 및 치료 방법 결정

중증도와 시급성에 따라 일반 외래 환자와는 별도로 운영하는
빠른 진료 제도를 구축, 활발하게 운영 중 ↔ 본원은 비활성화

팀 구성

팀장	간호국	안세현
간사	기획팀	최정인
팀원	간호국 영상의학과 진료협력팀 QI실	이정인 이미정 서정원 이현중 서현주 정진혁 김민정 조은별 이지현 김주라 정다은

핵심지표 및 목표

핵심지표

월 평균 적용 환자 수(명)

지표정의

정의 : 월 평균 원스톱 트랙을 적용한 환자의 수

분자 : 원스톱을 적용한 누적 환자 수

분모 : 조사 기간의 개월 수

목표설정

현수준 : 4.4명/월



목표 : 30.0명/월

설정 근거 : 현 수준 대비 약 7배 이상 증량

자료수집

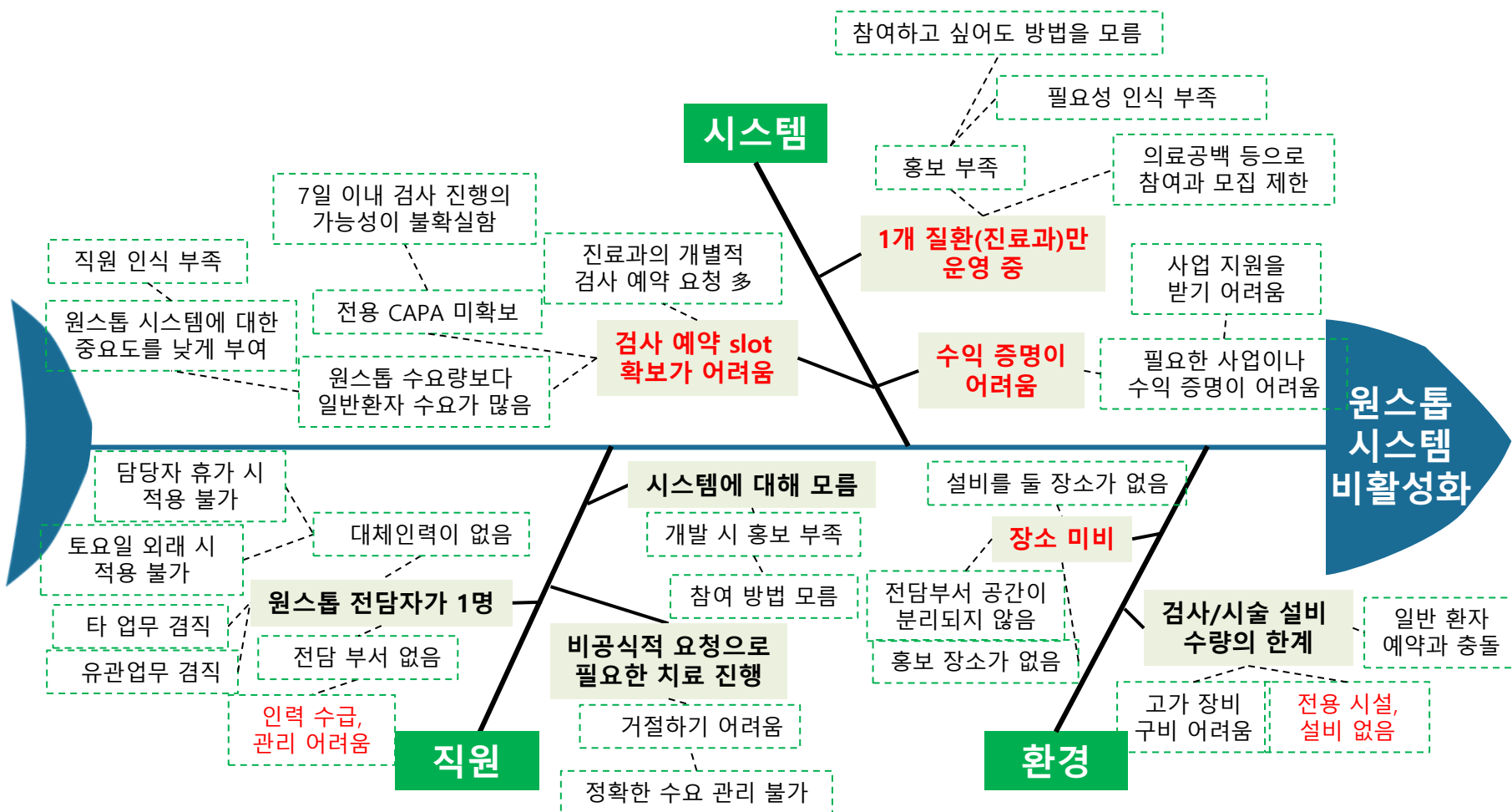
수집방법 : EHR 원스톱 모니터링 시스템을 활용

수집기간 : 1차 - 2024년 8월 1일 ~ 2024년 12월 31일

2차 - 2025년 1월 1일 ~ 2025년 10월 31일

원인분석

1. Fishbone chart 원인분석 결과

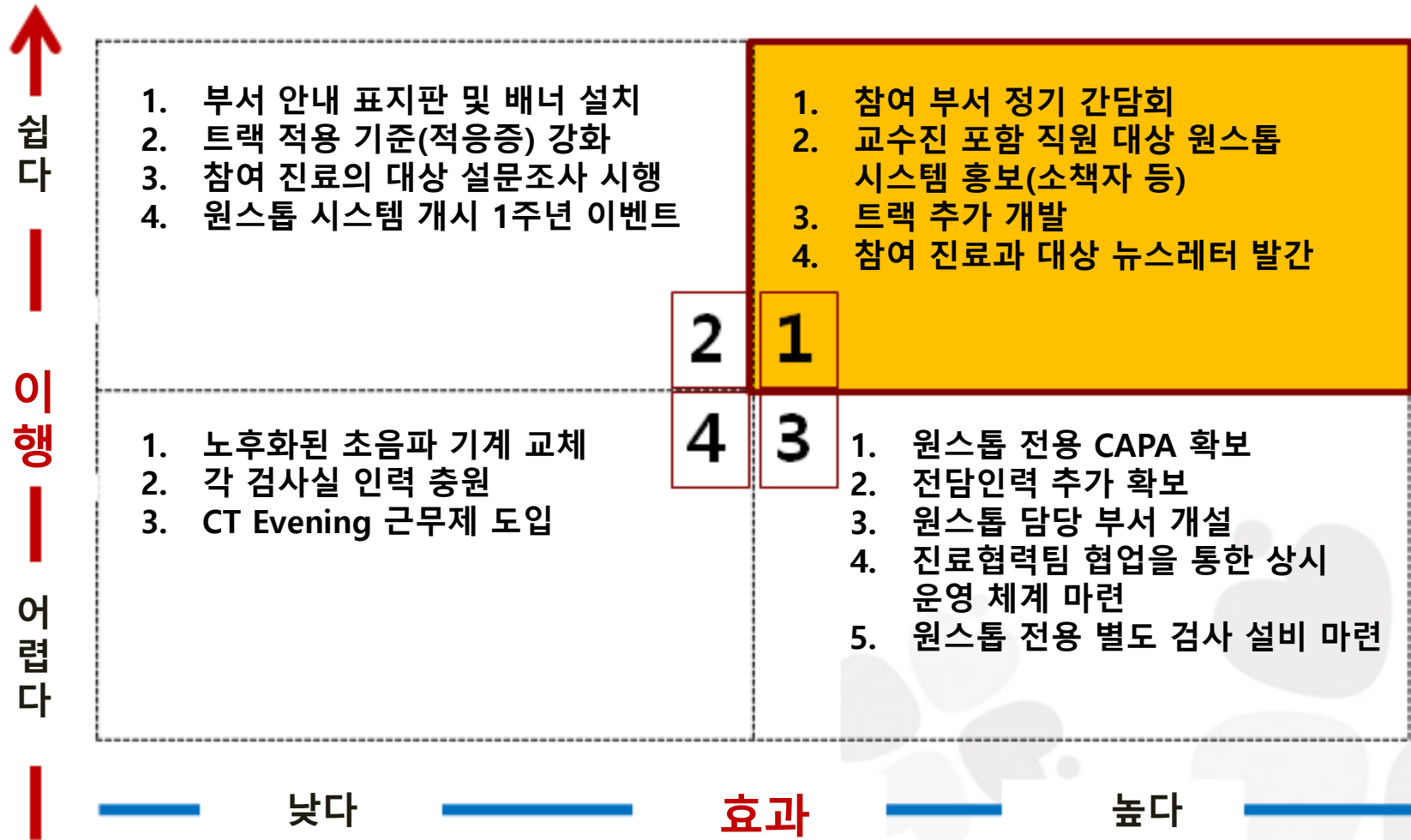


1. 도출된 개선전략 내용

시스템	직원	환경
• 트랙 추가 개발 • 원스톱 전용 CAPA 확보 • CT Evening 근무제 도입 • 참여 부서 정기 간담회 • 트랙 적용 기준(적응증) 강화 • 참여 진료의 대상 설문 조사 시행 • 원스톱 시스템 개시 1주년 기념 이벤트	• 전담 인력 추가 확보 • 원스톱 담당 부서 개설 • 진료협력팀 협업을 통한 상시 운영 체계 마련 • 교수진 포함 직원 대상 원스톱 시스템 홍보 (소책자 등) • 참여 진료의 대상 설문 조사 시행 • 원스톱 시스템 개시 1주년 기념 이벤트 • 참여 진료과 대상 뉴스레터 발간	• 부서 안내 표지판 및 배너 설치 • 원스톱 전용 별도 검사 설비 마련 • 노후화된 초음파 기계 교체 • 각 검사실 인력 충원

개선전략

2. 개선전략 우선순위 선정



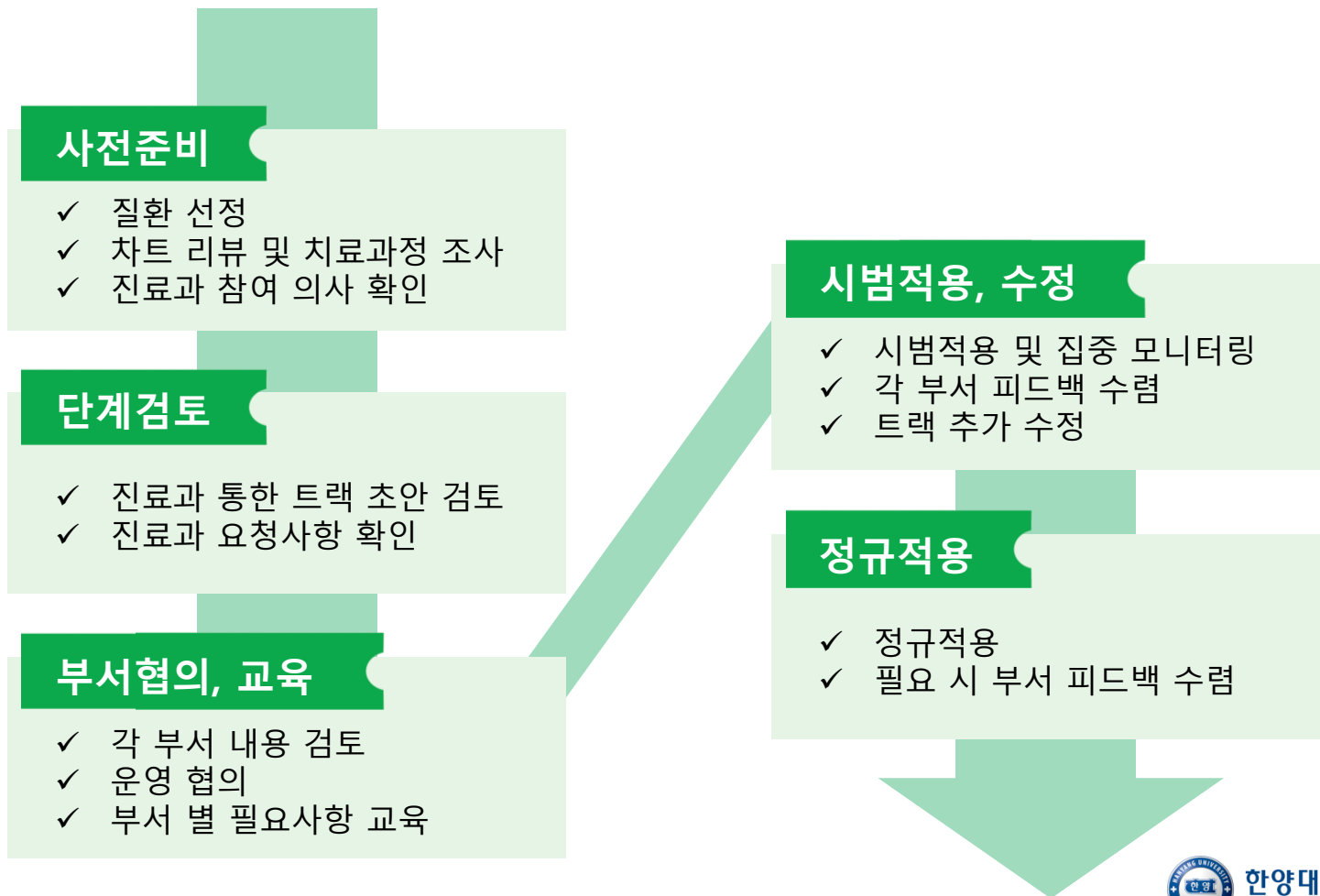
3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
1개 질환(진료과)만 운영 중	트랙 추가 개발	이정인 이미정 안세현 서정원 이현중 QI실	25.2.1~
- 시스템에 대해 모름 - 참여 방법 모름	참여 진료과 대상 뉴스레터 발간	안세현 최정인 QI실	25.6.1~
홍보 장소가 없음	부서 안내 표지판 및 배너 설치	안세현 서현주 QI실	25.4.23 ~25.5.30
- 전용 CAPA 미확보 7일 이내 검사 진행의 가능성이 불확실함	원스톱 전용 CAPA 확보	서정원 이현중 안세현 QI실	25.3.17~
- 직원 인식 부족 - 시스템에 대해 모름 - 개발 시 홍보 부족 - 필요한 사업이나 수익 증명이 어려움 - 사업 지원을 받기 어려움	참여 부서 정기 간담회	이정인 이미정 안세현 서정원 이현중 QI실	25.6.1~
	참여 진료의 대상 설문조사 시행	이정인 이미정 안세현 QI실	25.7.15~
	원스톱 시스템 개시 1주년 기념 이벤트	안세현 QI실	25.8.1

개선활동 내용

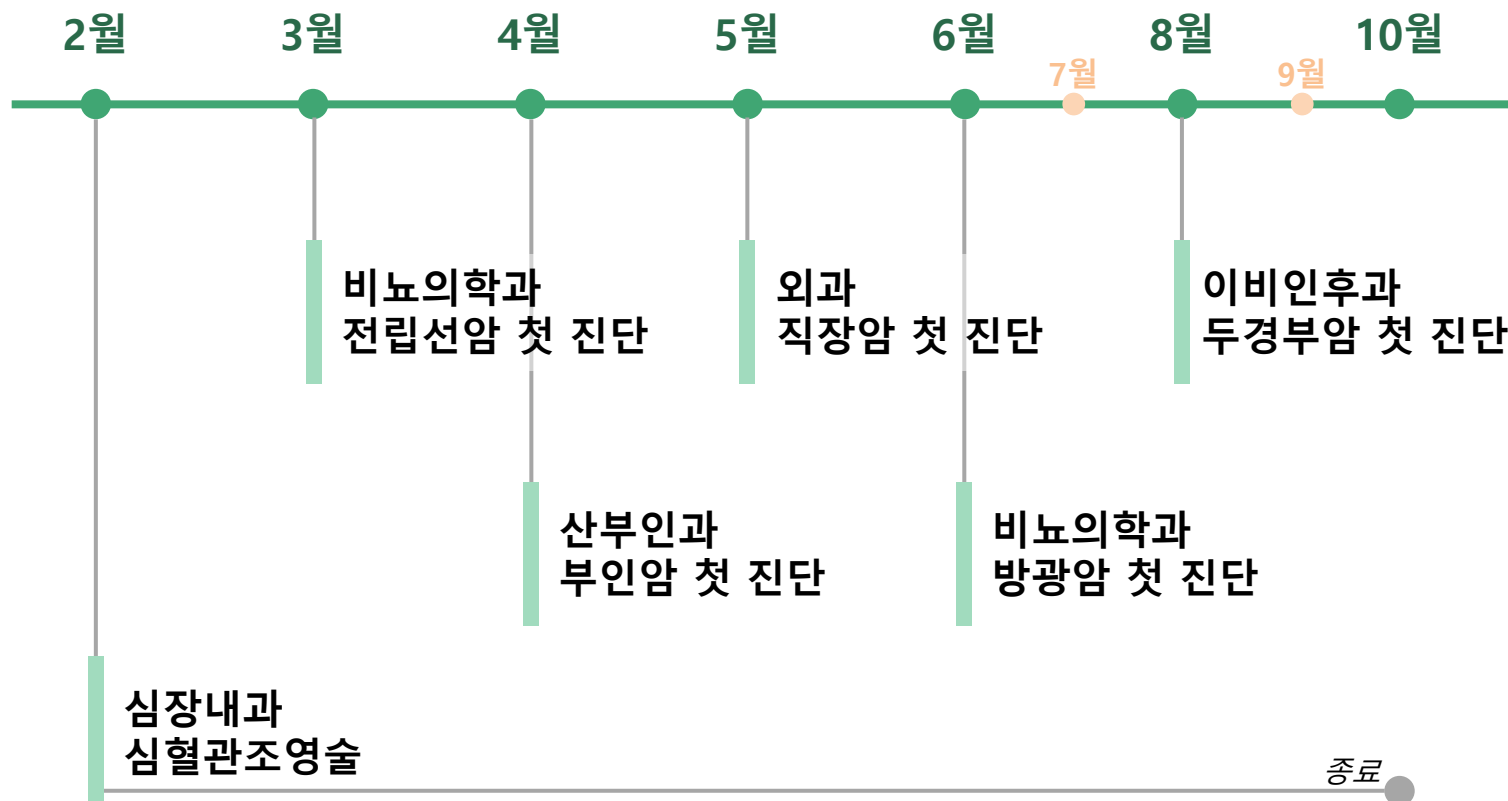
1. 트랙 추가 개발

- 트랙 : 원스톱 시스템 적용을 위해 **질환 별로 필요한 치료 절차, 스케줄** 등을 정리한 표



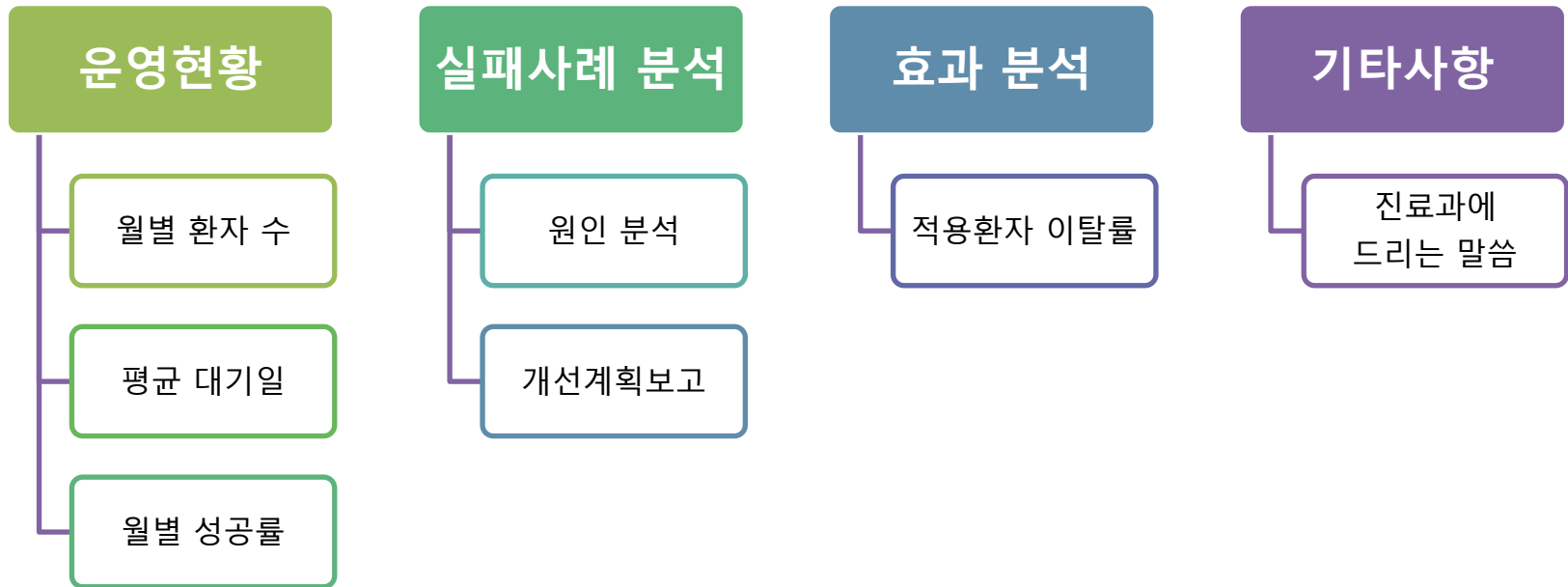
1. 트랙 추가 개발

- 매월 1가지 질환 씩 트랙 추가 개발
- 치료의 적시성 향상에 유의미한 도움이 되는지 판단하여 개발 적용



개선활동 내용

2. 참여 진료과 대상 뉴스레터 발간



개선활동 내용

2. 참여 진료과 대상 뉴스레터 발간

1. 원스톱 시스템 운영 현황 (24.8월~25.5월)

가. 운영현황 - 2025년 2월부터 매월 운영위원회, 진료부서장회의를 통해 보고



	2024년					2025년				
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
Y 건수	6	2	2	3	6	9	12	25	43	46
N 건수	0	1	0	0	0	1	1	2	9	3
E 건수	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
성공률 (%)	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%	92.3%	89.3%	79.6%	90.2%

2. 적용 실패 사례 분석

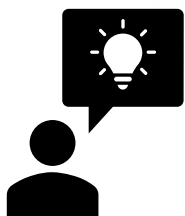
월	결과(대기일)	사유	개선사항
24.9	N(+8)	검사 CAPA 부족	
25.1	N(+10)	담당자 휴무	휴가일정 공유
25.2	N(+0)	담당자 휴무	휴가일정 공유
25.3	N(+14) N(+11) 기타(+11)	WBBS CAPA 부족 WBBS CAPA 부족 환자 거절	WBBS 고정 CAPA 요청 및 확보
25.4	N(+12) N(+14) N(+21) N(+11) N(+12) N(+4) N(+21) N(+8) N(+12)	WBBS CAPA 부족 WBBS CAPA 부족 담당자 휴무(토요일) WBBS, CT CAPA 부족 WBBS, CT CAPA 부족 WBBS, CT CAPA 부족 WBBS, MRL CT CAPA 부족 담당자 휴무	휴가일정 공유 각종 검사 시행 건수 비교분석 시작 WBBS 추가 CAPA 확보 방안 논의 및 구성 완료
25.5	N(+10) N(+11) N(+10)	담당자 휴무 담당자 휴무 담당자 휴무	원스톱 전담자 추가 인력 요청

가. 4월 검사 예약 지연 문제

- 문제 개요 : 4월 3~5주차 검사 지연 사례 급증, 4월 성공률이 80% 미만으로 급감
- 조사 내용 : WBBS, CT 검사 불가능하여 지연
- 해결 방안

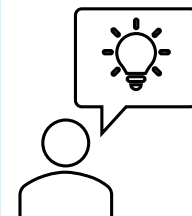
- 1) 각종 검사 시행 건수 비교분석 및 전용 CAPA 확보 논의
→ CT, WBBS 지연에 대해 원스톱 시스템 가동이 불가능할만큼 전체 검사량이 많았는지 비교분석
→ 검사량 자체가 늘어났다면 전용 CAPA 요청 예정
- 2) WBBS 추가 CAPA 확보
→ 4월 3, 4, 5주차 peak time(병목현상) 이후 검사 예약 원활하여 시행 보류
→ 이후 검사량 다시 증가할 경우, CAPA 확장에 대해 논의 예정

나. 원스톱 전담자 추가 인력 요청 : 추가 인력 또는 담당부서 지칭에 대해 협의 중



우리 진료과의 이탈률이 높은 것 같은데,
여기에 대한 개선방안은 뭐가 있나요?

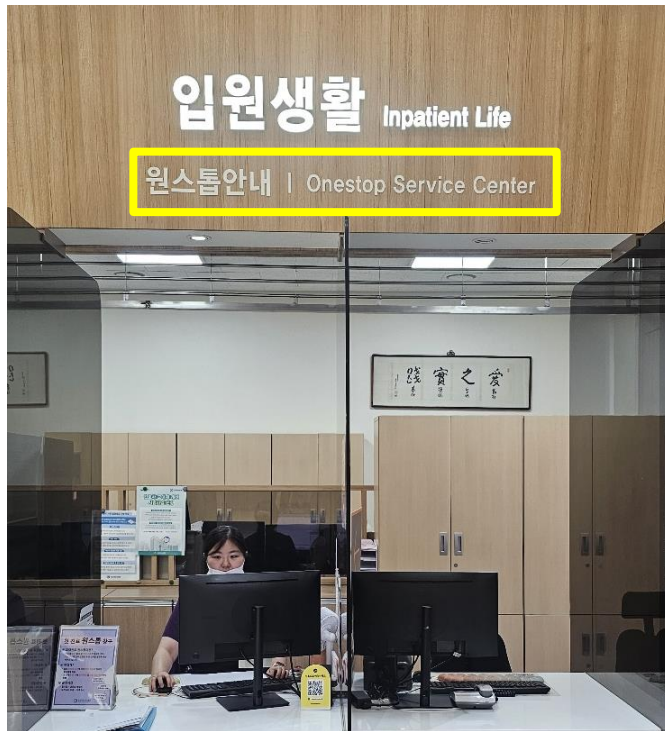
분석 결과 해당 진료과의 이탈률은...
타과 대비 해당 진료과의 특성은...
이탈환자의 특성은...
향후 어떤 활동을 준비중이며...



개선활동 내용

3. 부서 안내 표지판 및 배너 설치

- 부서 위치 안내 표지판 제작



개선활동 내용

4. 원스톱 전용 CAPA 확보

- 월별 적용 현황 모니터링 결과를 바탕으로 필요 수량 확인
- 각 검사실 협업 통해 원스톱 ~ 일반 환자 **검사 시간 분리**
- MRI(4/1), CT(7/22) 개시

구분	예약시간	인원	정...
A	2025-04-30 14:30	수	0 1
A	2025-04-30 15:00	수	0 1
A	2025-04-30 18:30	수	0 1

10:00 14:30 15:00~18:00 1번방PM

☐ 예약지

전용 시간은 배경이 분홍색



안내

평일 15:00 ~ 15:59 시간 사이의 MRI 검사는
원스톱 대상자 전용 예약시간입니다.
일반 환자는 해당 시간을 피해서 다른 시간으로 예약해 주십시오.

안내

평일 08:30 ~ 08:45 시간 사이의 CT 검사는
원스톱 대상자 전용 예약시간입니다.
일반 환자는 해당 시간을 피해서 다른 시간으로 예약해 주십시오.

해당 시간 클릭 시
안내 팝업 생성

개선활동 내용

4. 원스톱 전용 CAPA 확보

- 점유율 분석을 통한 CAPA 조정

13 QI실

2. (2025년도 CQI) 원스톱 시스템 확장

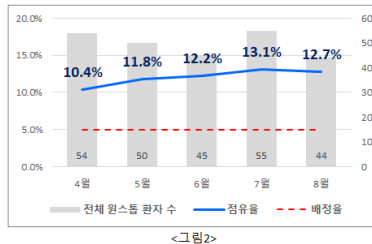
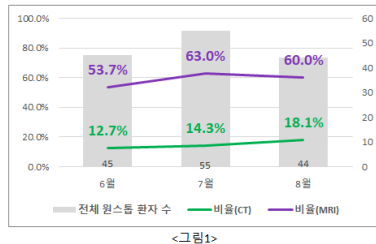
다. CAPA 점유 분석 및 조정

1) CT, MRI : 지정 시간 활용 <그림1>

- 전용 시간대에 검사를 받은 환자 중 원스톱 환자가 차지하는 비율
- CT 비율이 20% 미만 → 수요량 대비 과배정으로 판단, CAPA 축소 시행
- 08:30am, 8:45am은 **현행 유지**, 9:00am은 **제한 해제** (의료정보팀에 9/19 의뢰, 9/22 반영완료)

2) WBBS : 주당 8명 환자 배정 <그림2>

- 매주 8명(핵의학과 전체 CAPA 중 5%)



[운영위원회 보고 자료]

제목 업무 개발 의뢰서 - EHR 통합검사예약 원스톱 전용 CAPA 변경 건(CT)

요청부서	부서명	QI실	직위	계장	의뢰자	김주라
	전화번호	031-560-2776	전자메일	2197339@hyumc.com		

의뢰내용

- 귀 팀의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 구리병원에서는 2025년 Top Down QI 활동을 통해 원스톱 시스템을 지속 개발, 유지하고 있으며, 개선활동의 일환으로 EHR 통합검사예약 화면에서 CT 특정 시간의 검사 예약 CAPA를 원스톱 전용으로 표시하고 있습니다.
- 이에 따라 월별 이용량 분석을 통해 CAPA 제한을 다음과 같이 변경하고자 업무 개발을 의뢰드립니다.

- 아 래 -

- 통합검사예약화면 - 조건에 해당하는 시간은 아래의 빨간색 박스 칸을 '분홍색 배경'으로 표시가. 변경 요청안

1) 현재 분홍색 배경으로 표시되는 시각 : 8:30am, 8:45am, 9:00am

2) 변경 후 : 8:00am, 8:45am (9시 정각 삭제)

Breast MRI / CE+DW[3D] (60)

[CAPA 변경 요청]

분석 결과를 운영위원회 보고, 점유율에 따른 전용 CAPA 보유량 증감

→ 지속적인 감시를 통한 탄력적 CAPA 운영

개선활동 내용

5. 참여 부서 정기 간담회

- 원스톱 전담자, 진료과 외래 간호사, 관련 검사실 등
- 첫 환자 적용 시, 시범적용 종료 시, 정기적용 후까지 기본 **3회 이상 간담회 시행**

관련 검사실

- ✓ CAPA 운영 피드백
- ✓ 추가 요청사항
- ✓ 환자 만족도 관찰

진료과 의료진

- ✓ 추가 요청사항
- ✓ 환자 만족도 관찰
- ✓ 지속 사용 논의
- ✓ 추가 개발 문의



원스톱 전담자

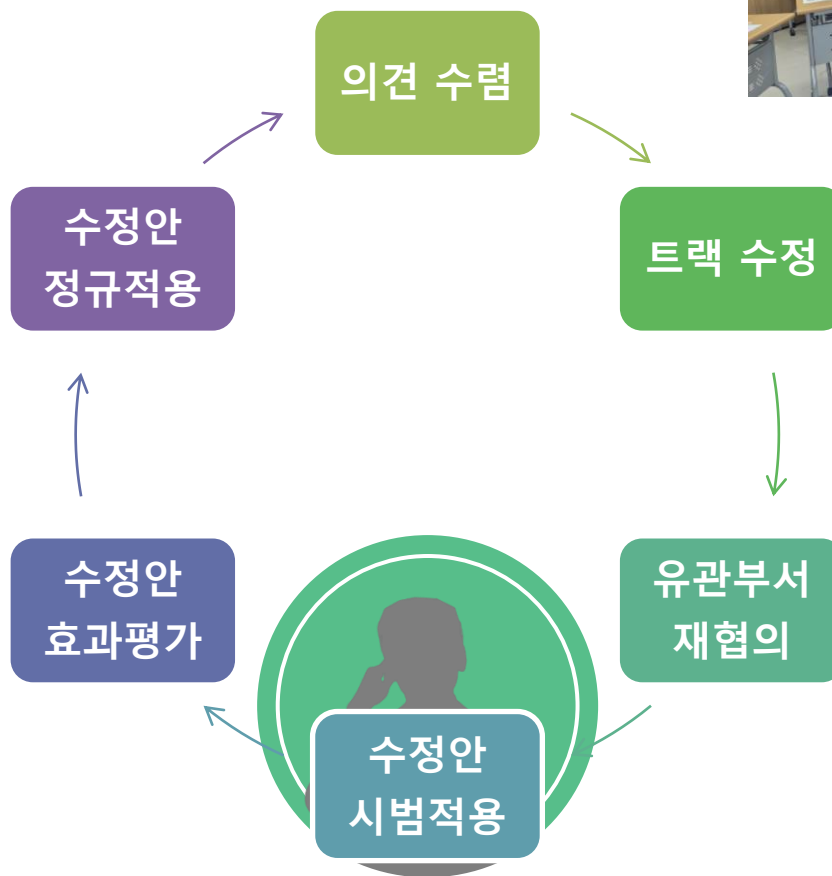
- ✓ 적용 피드백
- ✓ 환자 만족도 관찰
- ✓ 추가 개발 문의
- ✓ 모니터링 결과 공유

“무엇이 더 필요할까?”

개선활동 내용

5. 참여 부서 정기 간담회

- 운영에 관한 건의, 제언 등을 반영하여 추가 개선 진행



개선활동 내용

6. 참여 진료의 대상 설문조사 시행

- 1개월 이상 참여한 진료의를 대상으로 설문조사 시행
- 만족도 및 사업 지속 가능성 평가, 개선방안 탐색

7. 원스톱 시스템 개시 1주년 기념 이벤트

- 2025년 8월 1일(원스톱 도입 1주년) 참여 의사직 대상 커피 쿠폰 발송
- 참여 진료의 대상 설문지와 함께 배부

5. 원스톱 시스템 도입 이후, 무엇이 가장 도움이 되었습니까?

① CT, MRI 등 검사 대기일 단축 ② 환자 치료 일정 단축
③ 검사실/간호사의뢰 소통 간소화 ④ 환자 만족도 향상
⑤ 환자 이동을 저하

[2025년도 Top Down Q[활동]

원스톱 시스템 만족도 조사 - 의사직 -

안녕하십니까? Top Down Q[활동입니다.
우리 병원은 매년 병원 직원, 의료 직 향상 활동을 진행하고 있으며, 이를 위한 개선활동으로
2025년부터 [원스톱 시스템]을 운영하고 있습니다.
본 설문지를 이용하는 교수님들은 대상으로, 사용 후 만족도를 아래와 같이 조사하고자 하오니
정확히 부탁드립니다. 설문 결과는 추가 개선활동을 도출하고, 시스템 효과 평가를 위한 통계자료로
활용됩니다. 모든 자료는 익명으로 처리됩니다.

1. 사업 참여 전, 우리병원에서 원스톱 시스템을 운영한다는 사실을 알고 계셨습니까?

① 자세히 알고 있었다. ② 이렇다 할 것 없고, 자세한 내용은 몰랐다.
③ 전혀 몰랐다.

2. 교수님께서 실제로 원스톱 시스템을 얼마나 자주 이용하고 계십니까?

① 1주일에 3회 이상 ② 1주일에 1~2회
③ 1개월에 2~3회 ④ 1개월에 1회 이하
⑤ 전혀 사용하지 않음.

3. 원스톱 시스템을 사용하는 이유는 무엇입니까? (복수선택 가능)

① 외래 간호사의 지원
② Q[질의 권유
③ CT, MRI 등 검사 예약이 편리해서(검사실과의 불편한 연계를 피할 수 있어서)
④ 병원 차원의 사일이어서
⑤ 치료 일정을 앞당길 수 있어서
⑥ 기타: (적절 기입) _____

4. 교수님께서 원스톱 시스템에 대해 전반적으로 만족하십니까?

① 매우 만족
② 만족
③ 보통
④ 불만족
⑤ 매우 불만족

덧붙여드립니다.

개선활동 결과

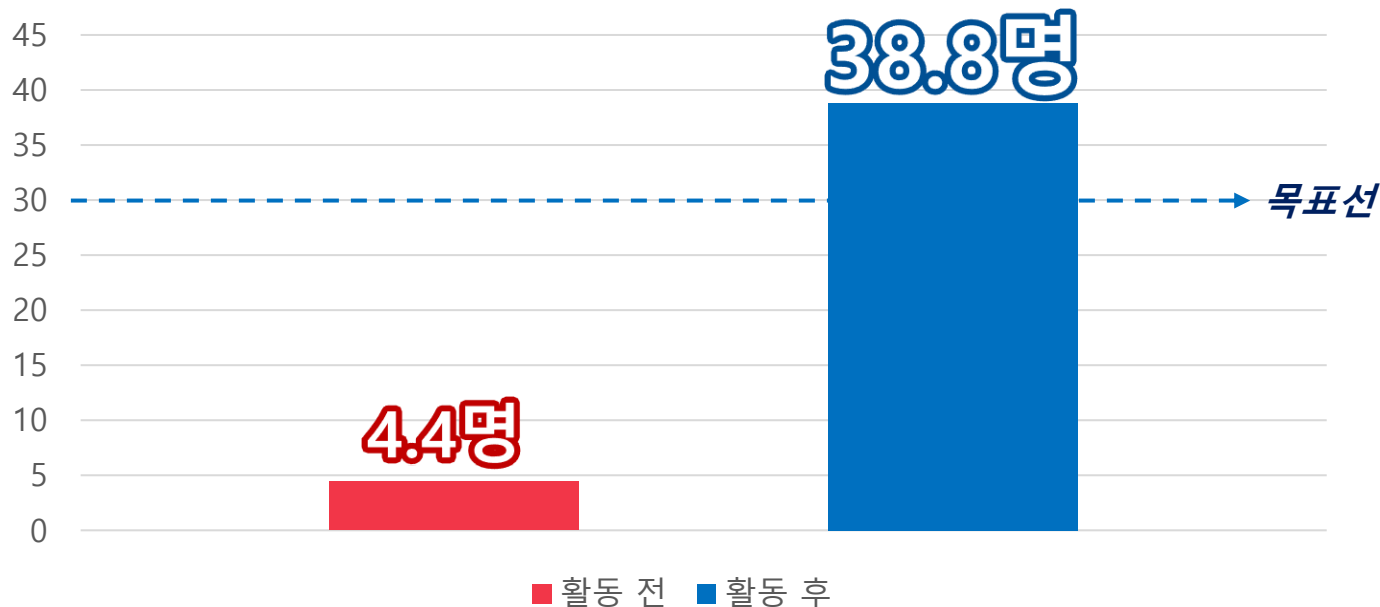
활동 전 : 2024.8.1~2024.12.31

활동 후 : 2025.1.1~2025.10.31

1. 핵심지표 결과 평가

- 월 평균 원스톱 트랙을 적용한 환자의 수는 매월 4.4명에서 **38.8명으로 상승함.**
- 활동 **목표**인 30명 이상을 **달성함.**

월 평균 원스톱 트랙 적용 환자 수(명)



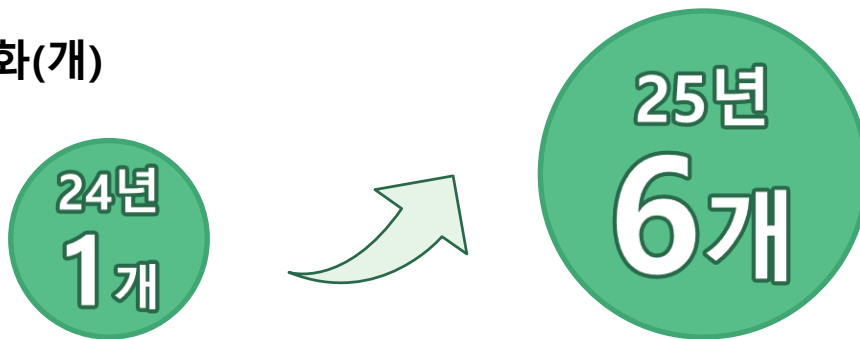
개선활동 결과

조사기간 : 2024.8.1~2025.10.31

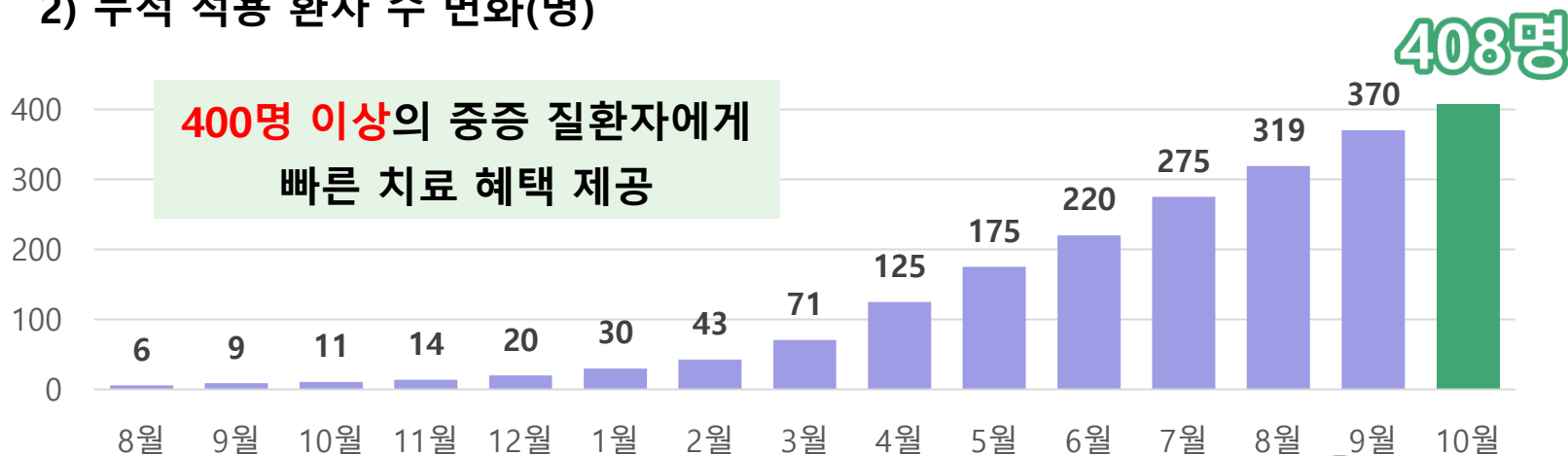
2. 핵심지표 외 효과 평가

가. 원스톱 시스템 활성화 평가

1) Track 개수 변화(개)



2) 누적 적용 환자 수 변화(명)



개선활동 결과

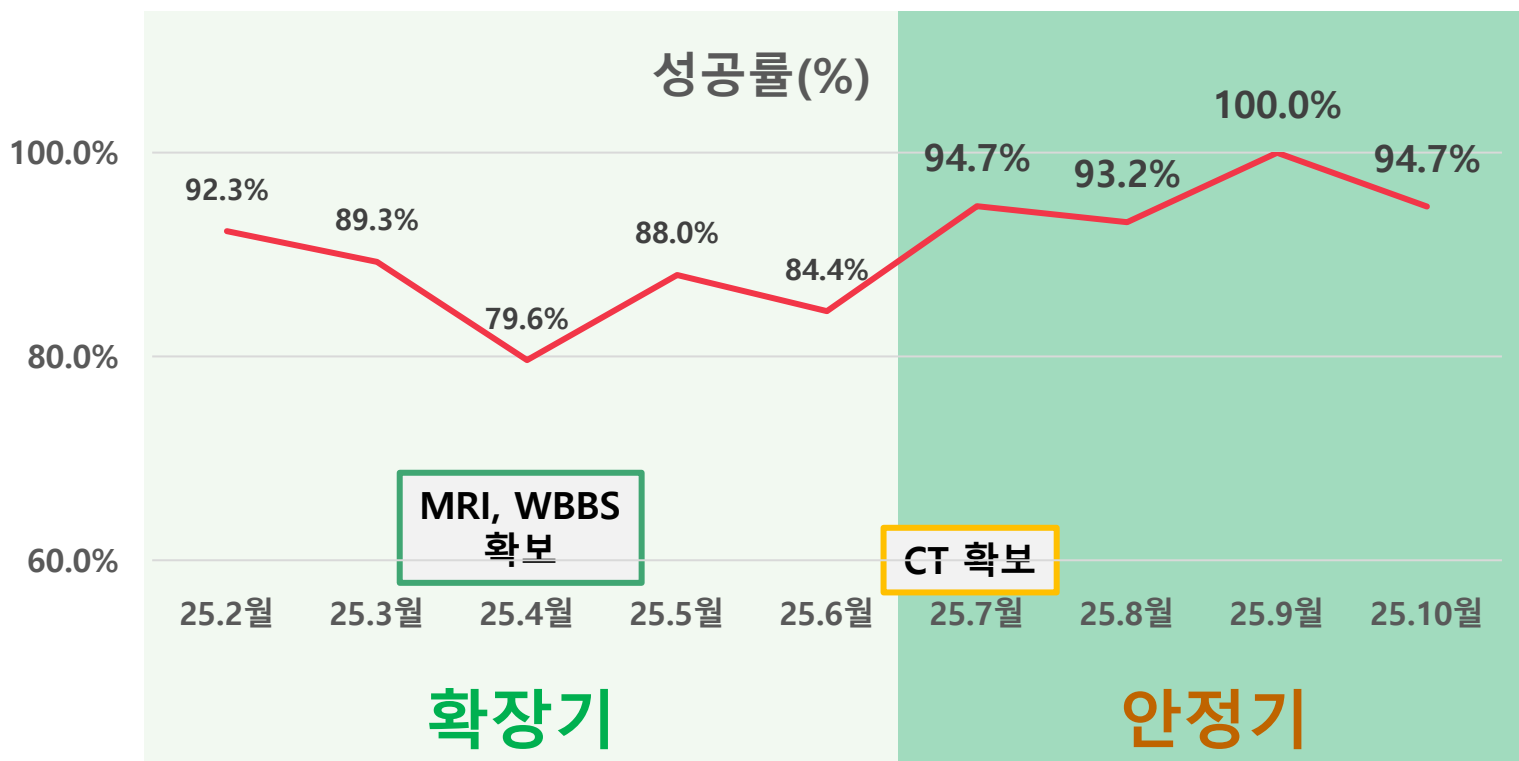
조사기간 : 2024.8.1~2025.10.31

2. 핵심지표 외 효과 평가

가. 원스톱 시스템 활성화 평가

3) 원스톱 적용 성공률 변화(%)

- QI활동 기간, CAPA 확보 및 안정화에 따라 성공률도 향상됨



개선활동 결과

조사기간 : 2024.8.1~2025.10.31

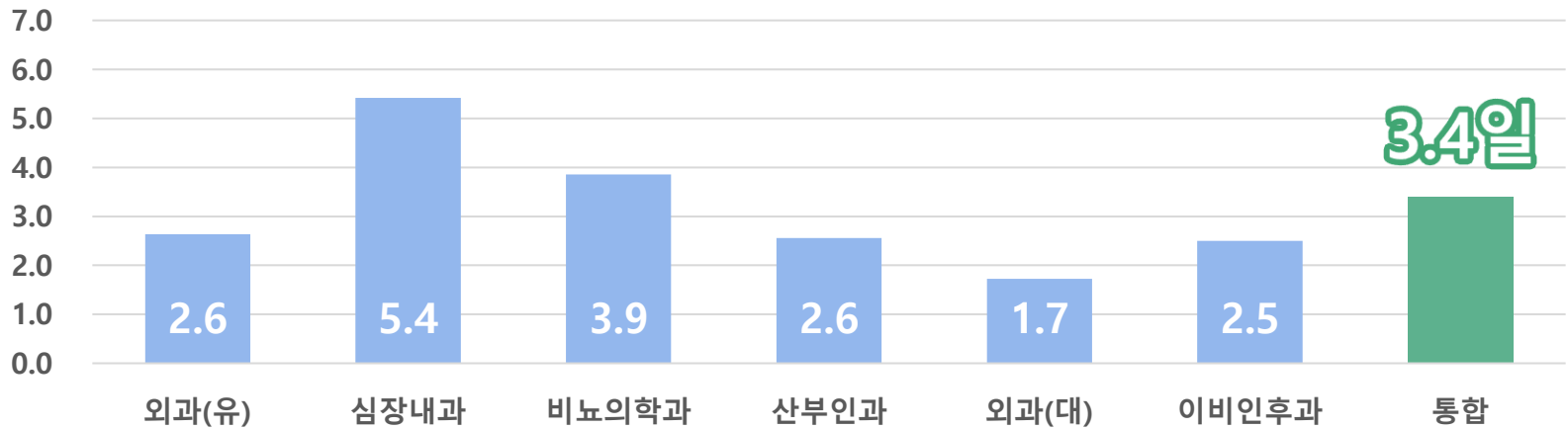
2. 핵심지표 외 효과 평가

가. 원스톱 시스템 활성화 평가

4) 원스톱 적용 환자 대기일수(일)

- 원스톱 적용 당일(진료일)로부터 예약제 검사를 수행하기까지 소요된 시간
- 원스톱 시스템은 7일 이내 치료 개시를 목표로 함.

대기일수



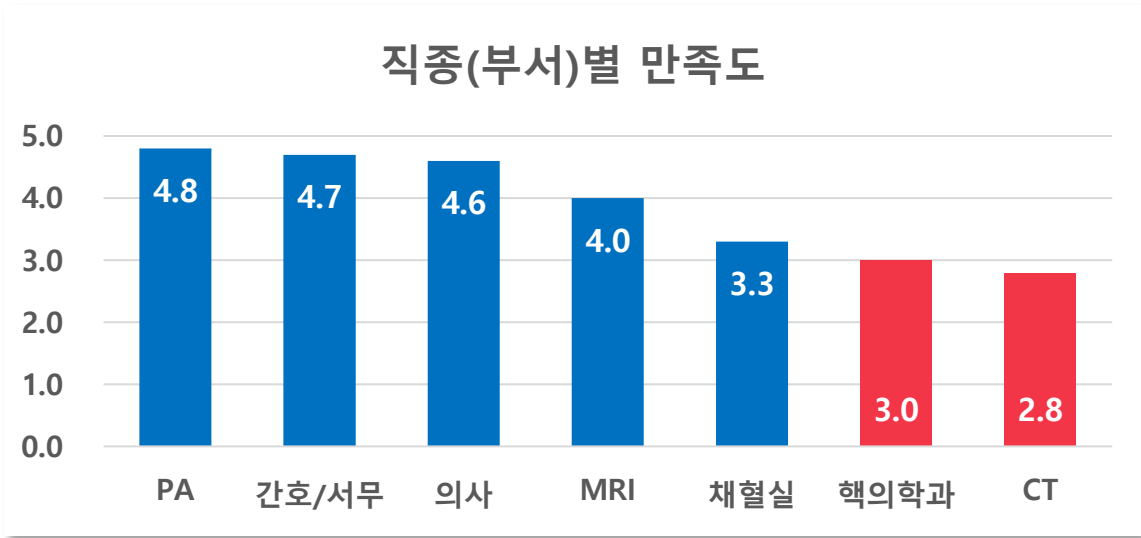
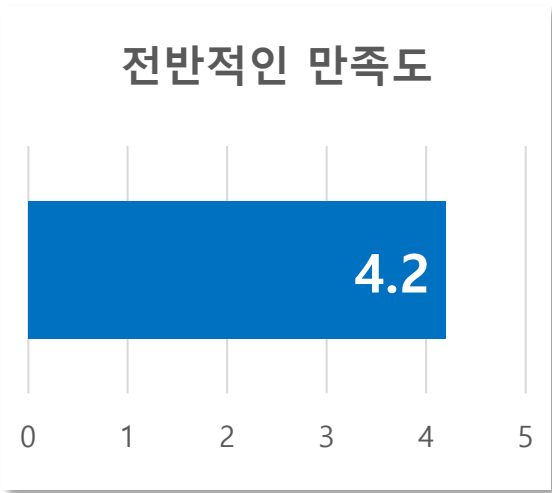
개선활동 결과

2025.9.15~2025.9.30, 원스톱 유관 부서 직원 32명
2025.7.28~2025.9.30, 원스톱 참여 의사직 9명

2. 핵심지표 외 효과 평가

나. 직원, 환자 만족도 조사

- 근무부서 간 만족도에 유의한 차이가 있음.(ANOVA $F=8.339$, $p<.001$)
- 의사직/간호·사무직/PA의 만족도보다 핵의학과/CT실의 만족도가 유의하게 낮음.



핵의학과, CT실 : '검사 일정 관리 어려움'을 토로
→ 전용 CAPA 시간이 없거나, 뒤늦게 도입된 부서
반면, 전용 CAPA 시간 도입 및 안정화가 끝난 **MRI실**은 만족도▲ **트랙 확장 의사**▲

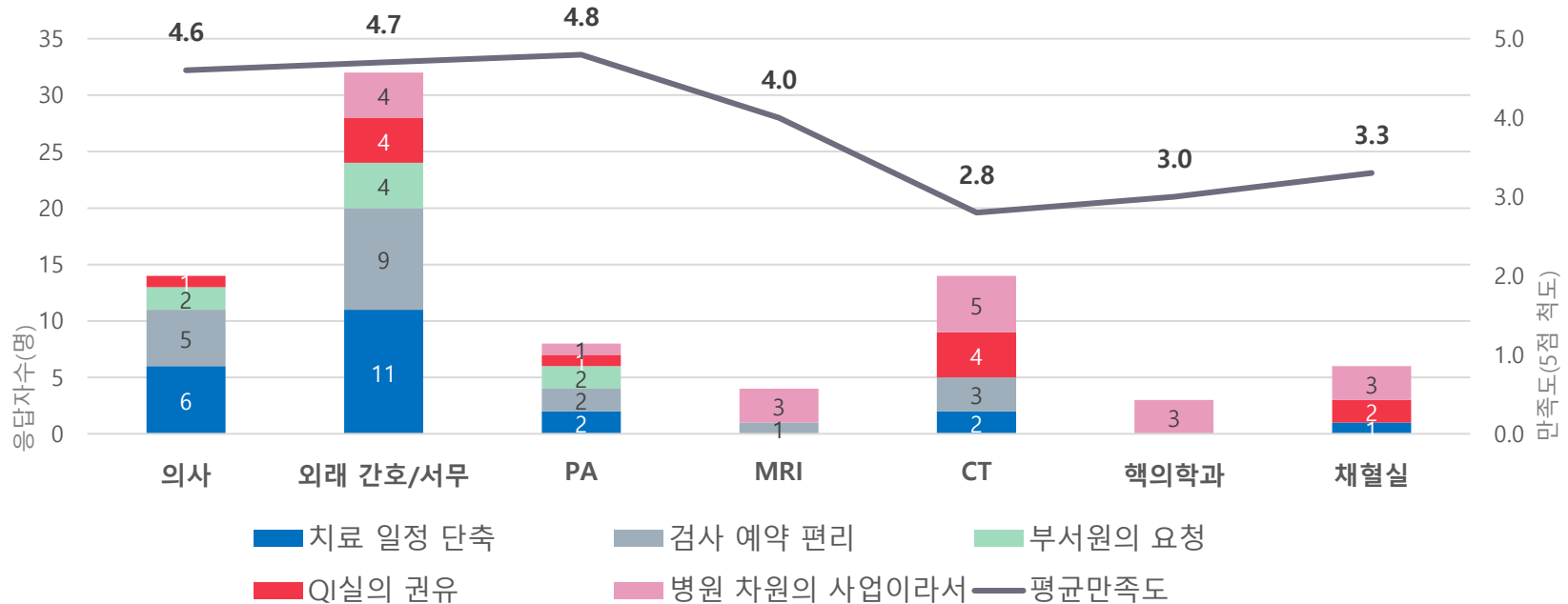
개선활동 결과

2025.9.15~2025.9.30, 원스톱 유관 부서 직원 32명
2025.7.28~2025.9.30, 원스톱 참여 의사직 9명

2. 핵심지표 외 효과 평가

나. 직원, 환자 만족도 조사

직종(부서)별 만족도 및 원스톱 시스템 참여 사유



치료일정 단축, 검사 예약 편리 등 **자발적 참여의사가 많을수록** 만족도가 높게,
병원 사업이라, 또는 QI실 권유 등 **타의적으로 참여한 직종일수록** 만족도가 낮게 나타남.

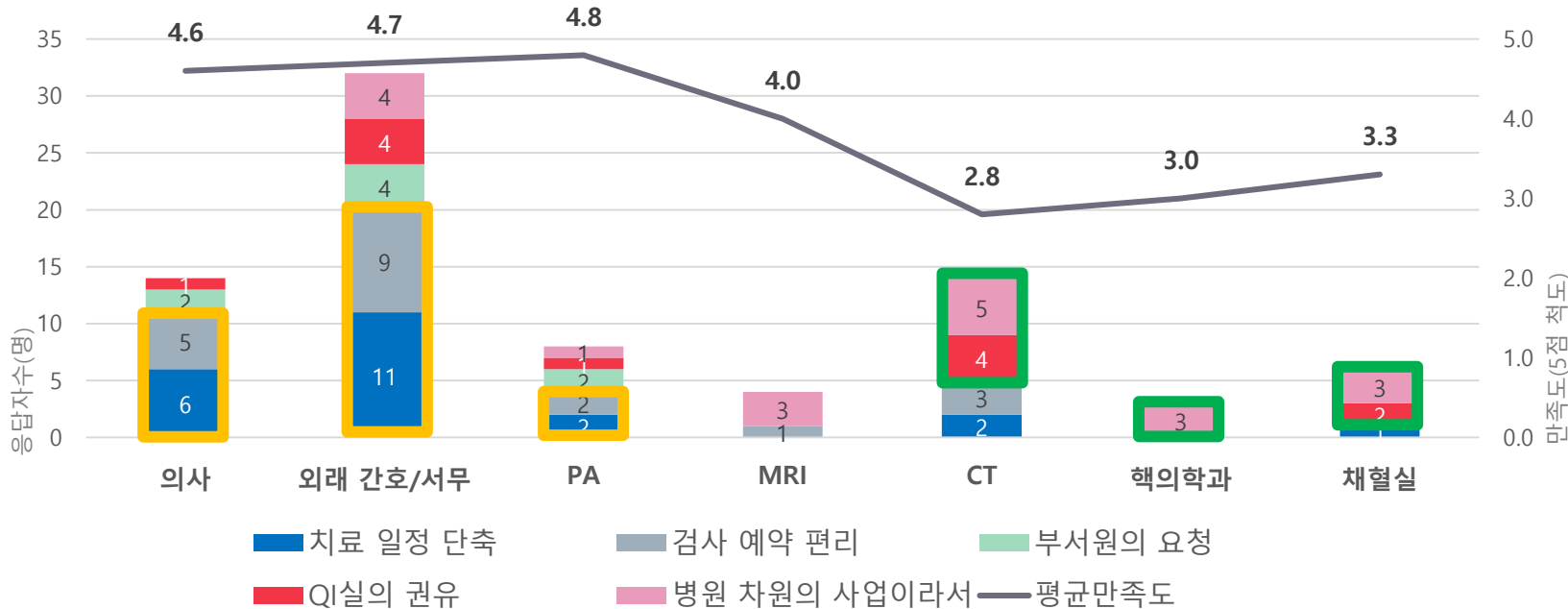
개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과 평가

2025.9.15~2025.9.30, 원스톱 유관 부서 직원 32명
2025.7.28~2025.9.30, 원스톱 참여 의사직 9명

나. 직원, 환자 만족도 조사

직종(부서)별 만족도 및 원스톱 시스템 참여 사유



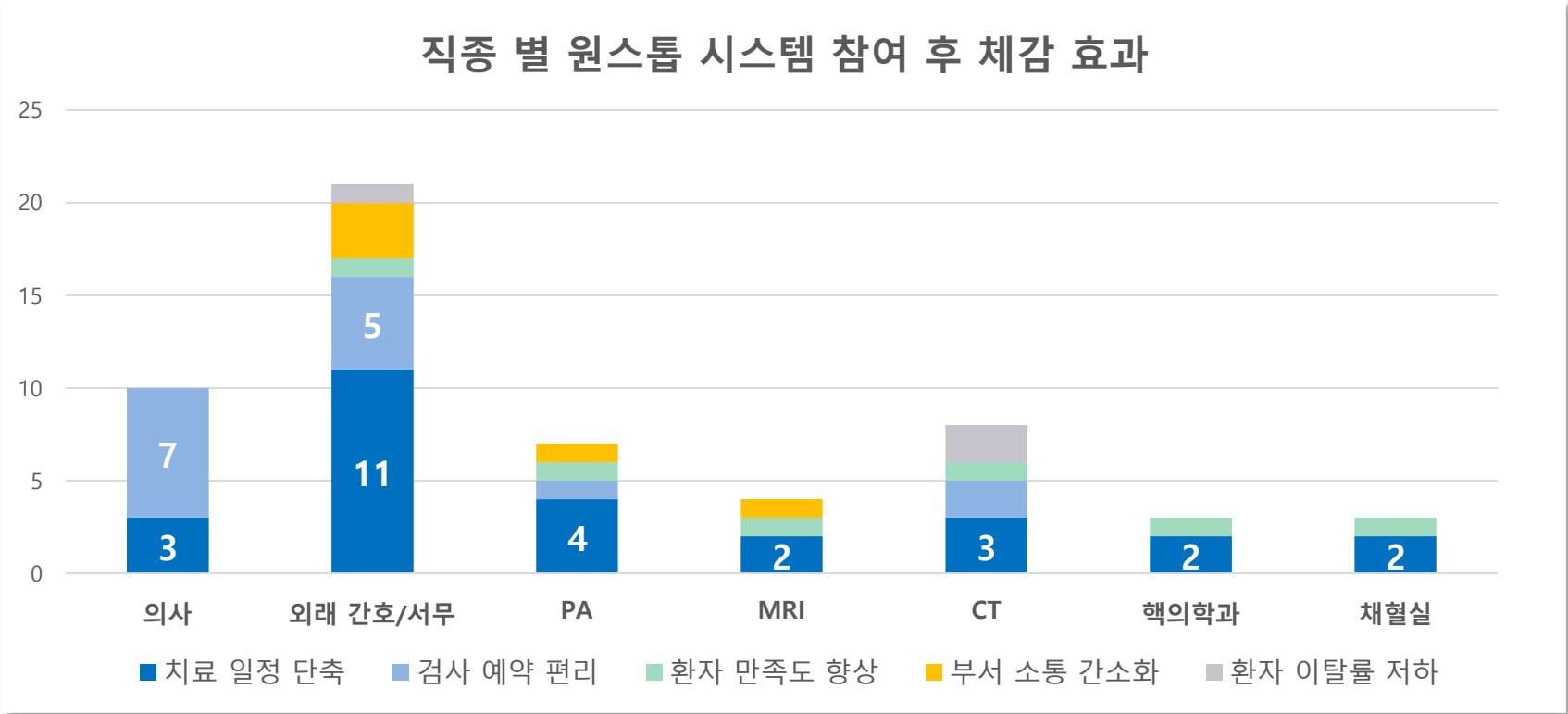
치료일정 단축, 검사 예약 편리 등 **자발적** 참여의사가 많을수록 만족도가 높게,
병원 사업이라, 또는 QI실 권유 등 **타의적**으로 참여한 직종일수록 만족도가 낮게 나타남.

개선활동 결과

2025.9.15~2025.9.30, 원스톱 유관 부서 직원 32명
2025.7.28~2025.9.30, 원스톱 참여 의사직 9명

2. 핵심지표 외 효과 평가

나. 직원, 환자 만족도 조사



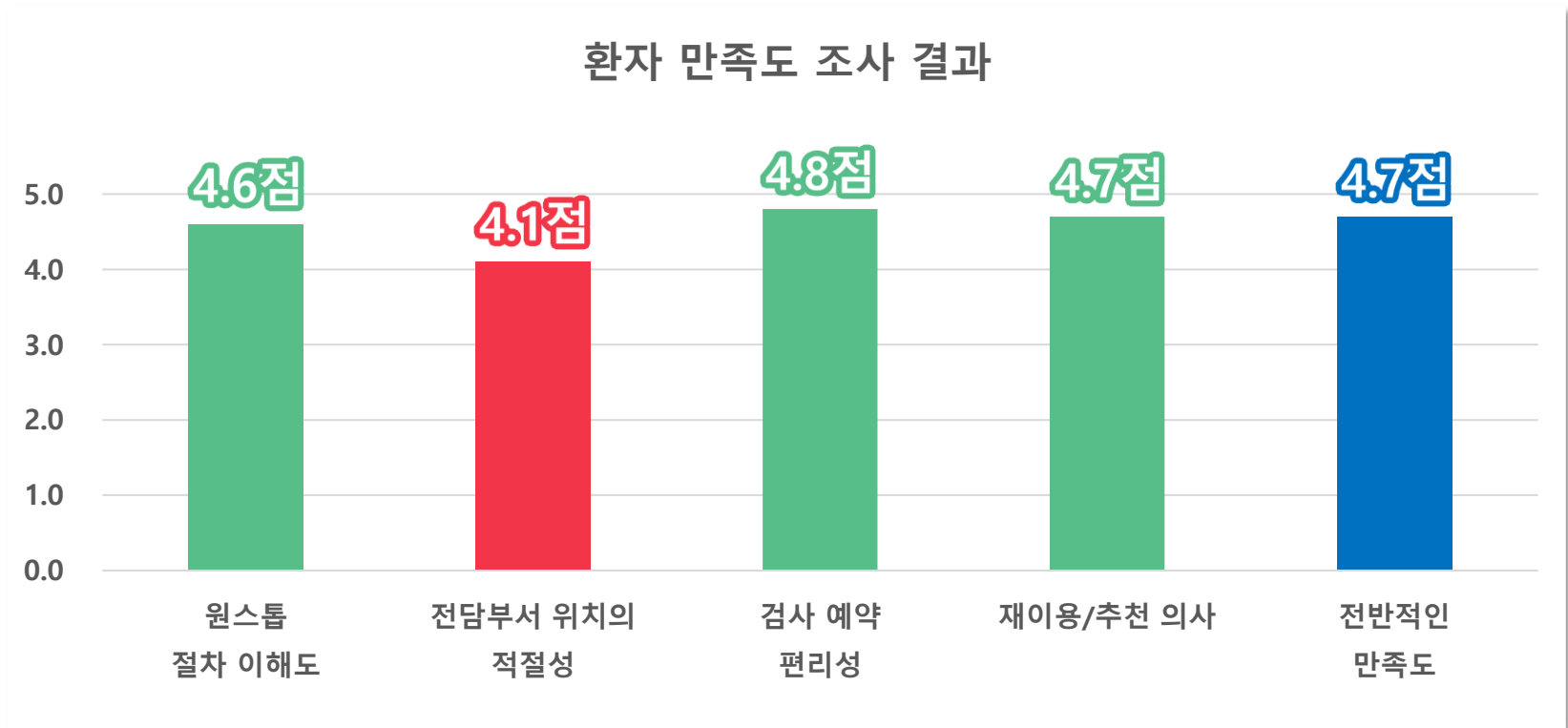
모든 직종, 부서에서 '치료 일정 단축'의 효과를 체감
'검사 예약 편리'는 진료파트에서 특히 높게 평가

개선활동 결과

2025.9.18~2025.10.24, 원스톱 적용 후 재진으로 방문한 환자 30명

2. 핵심지표 외 효과 평가

나. 직원, 환자 만족도 조사



대부분 긍정적으로 평가, 전반적인 만족도 4.7점
 그러나 전담부서의 위치를 찾기 어렵고, 장소가 협소하고 어수선했다는 의견 다
 → 전담부서 단독 장소 확보의 필요성 제기

개선활동 결과

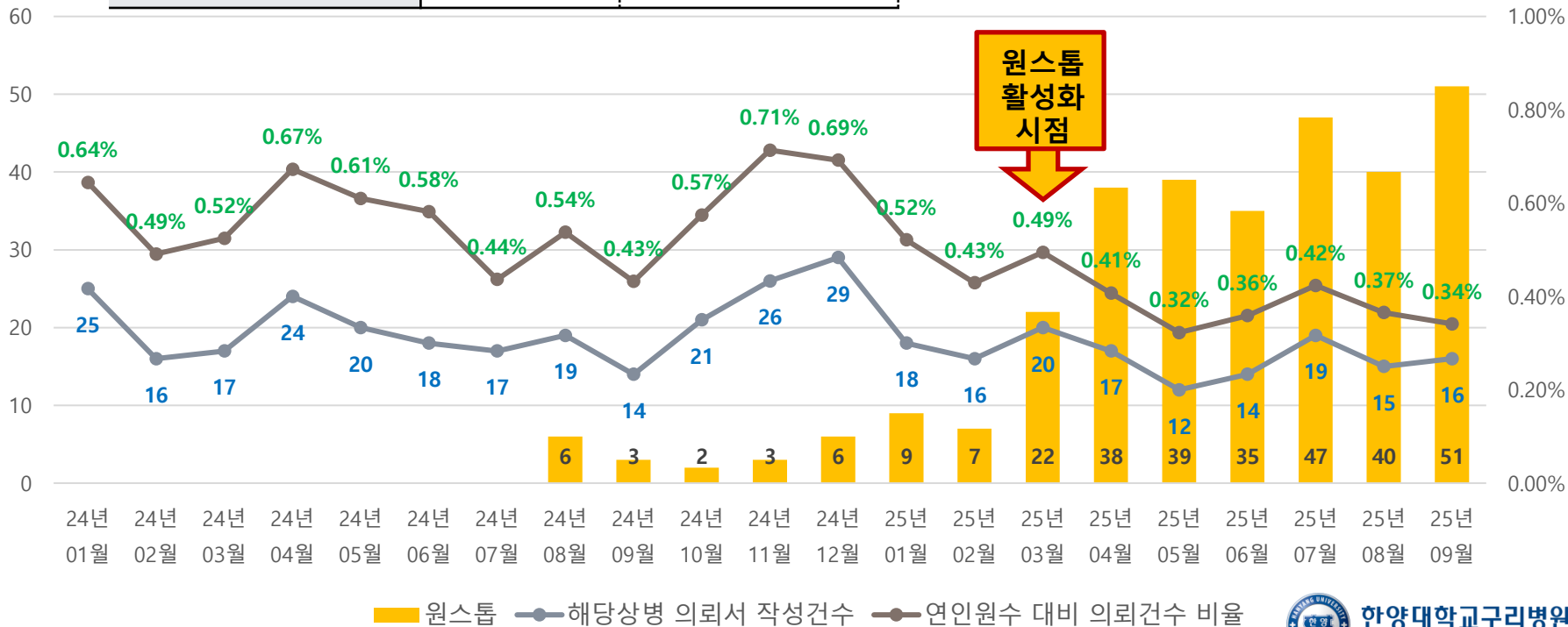
2. 핵심지표 외 효과 평가

조사기간 : 2024년 1분기 ~ 2025년 3분기

다. 원스톱 Track 상병 기준 이탈률 분석

	활성화 이전	활성화 이후
월별 의뢰서 건수	20건 내외	11~15건으로 감소
연인원수 대비 의뢰건수 비율	0.6~0.8%	0.3~0.4% (절반으로 감소)

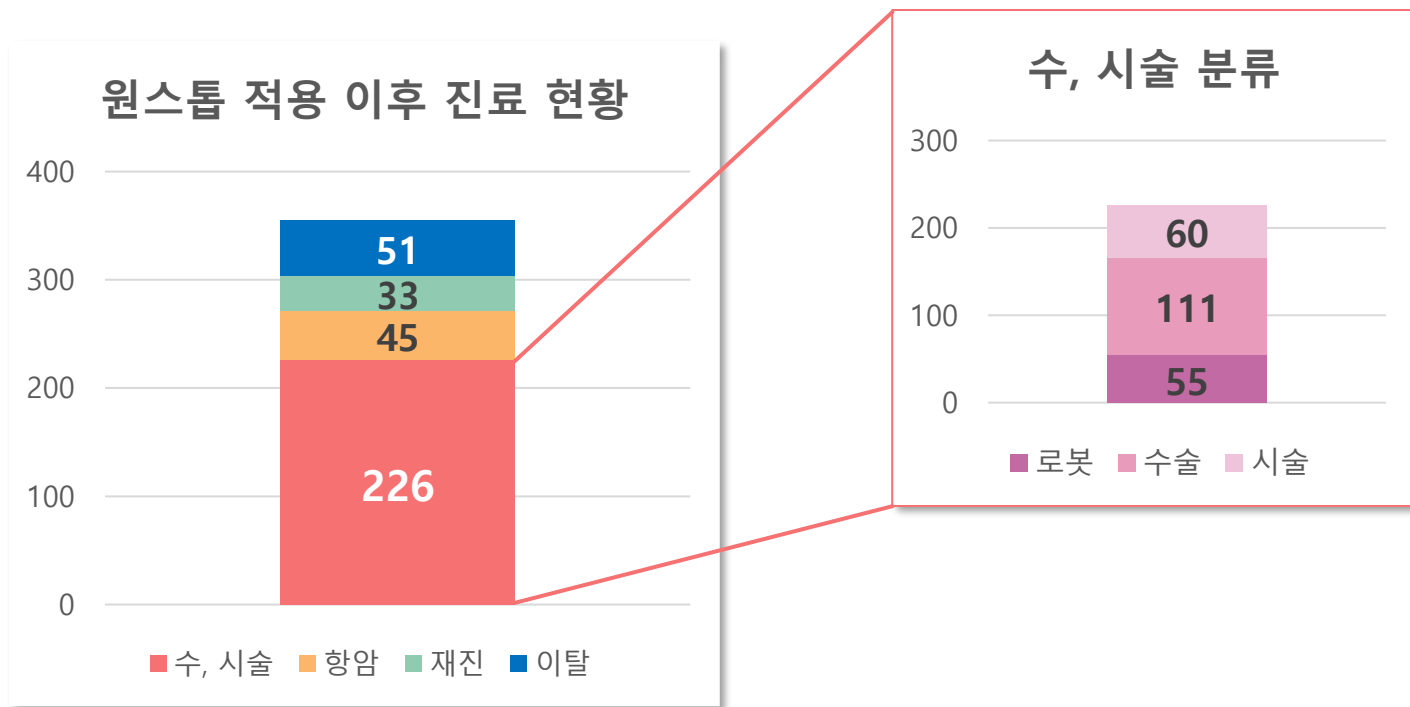
원스톱 시스템이 **활성화될수록**
해당 상병에 대한 타원으로의
의뢰서 작성 건수, 비율 모두 감소



2024.8.1~2025.9.30, 원스톱 적용환자 중 진료 예정자를 제외한 전수
(371명 중 355명)

2. 핵심지표 외 효과 평가

라. 원스톱 적용 환자의 치료 과정 추적 관찰



거취가 확인된 환자 중 **304명(85.7%)은 잔류**, 이 중 **226명(63.7%)는 수/시술까지**
51명(14.4%)은 원스톱 트랙 종료 이후 타원으로 이탈

→ 원스톱으로 대기일은 크게 축소, 그 밖의 이탈원인은 다른 해결방안을 찾아야

개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과 평가

마. 전산 추가 기능 개발

- 트랙 개발 과정에서 제안된 산정특례 정보 조회 기능 개발
- 각종 **평가(적정성평가 등)** 대상 **환자**의 개시일 확인을 통해 **협업 가능성 확보**
- 빠른 진료 체계 유지에 도움

외래 원스톱(Fast Track) 환자 모니터링

조회일자

2025-07-30 ~ 2025-08-29

진료과

상병코드	산정특례개시일	산정특례상병
C50.90	2025-07-31	C5090
C61	2025-08-26	C61

*NO	모니터링	비고	등	명	성별	나이	적용일	입력자	적용 진료과	임상진단	상병코드	산정특례개시일	산정특례상병	취소자	취소일자
1	Y	+1 CT, MRI, WBBS	00	하	F	60	2025-07-31	안세현	외과	Malignant neoplasm of breast u...	C50.90	2025-07-31	C5090		
2	Y	+1 WBBS, +2 CT, MRI	00	준	M	74	2025-08-26	이승욱	비뇨의학과	Malignant neoplasm of prostate	C61	2025-08-26	C61		
3	Y	+1 CT, MRI	00	김	M	67	2025-08-26	송병도	비뇨의학과	Abnormal findings on diagnosti...	R93.4				
4	Y	+4 CT, MRI, +5 WBBS	00	영	F	56	2025-08-07	김형석	외과	Malignant neoplasm of breast u...	C50.90	2025-08-04	C5090		
5		취소(진료과 자체해결~)...	00	옥	F	46	2025-08-13	김형석	외과	Intraductal carcinoma in situ of ...	D05.11	2025-08-12	D0511	안세현	2025-08-18
6	Y	+1 MRI, +3 CT, WBBS	00	만	M	71	2025-08-11	송병도	비뇨의학과	Malignant neoplasm of prostate	C61	2024-09-27	C61		
7	Y	+1 WBBS, +2 CT, MRI	00	란	F	66	2025-08-19	김형석	외과	Malignant neoplasm of breast u...	C50.90	2025-08-13	C5090		
8	Y	+1 MRI	00	자	F	59	2025-08-19	류기영	산부인과	Neoplasm of uncertain or unkn...	D39.19				
9	Y	+3 CT, MRI, +4 토르소(...	00	록	M	58	2025-08-01	황성환	외과	Malignant neoplasm of rectum	C20	2025-07-30	C20		
10	Y	+1 WBBS, MRI, +2 CT	00	임	F	70	2025-08-19	김형석	외과	Intraductal carcinoma in situ of ...	D05.10	2025-08-19	D0510		

개선활동 평가

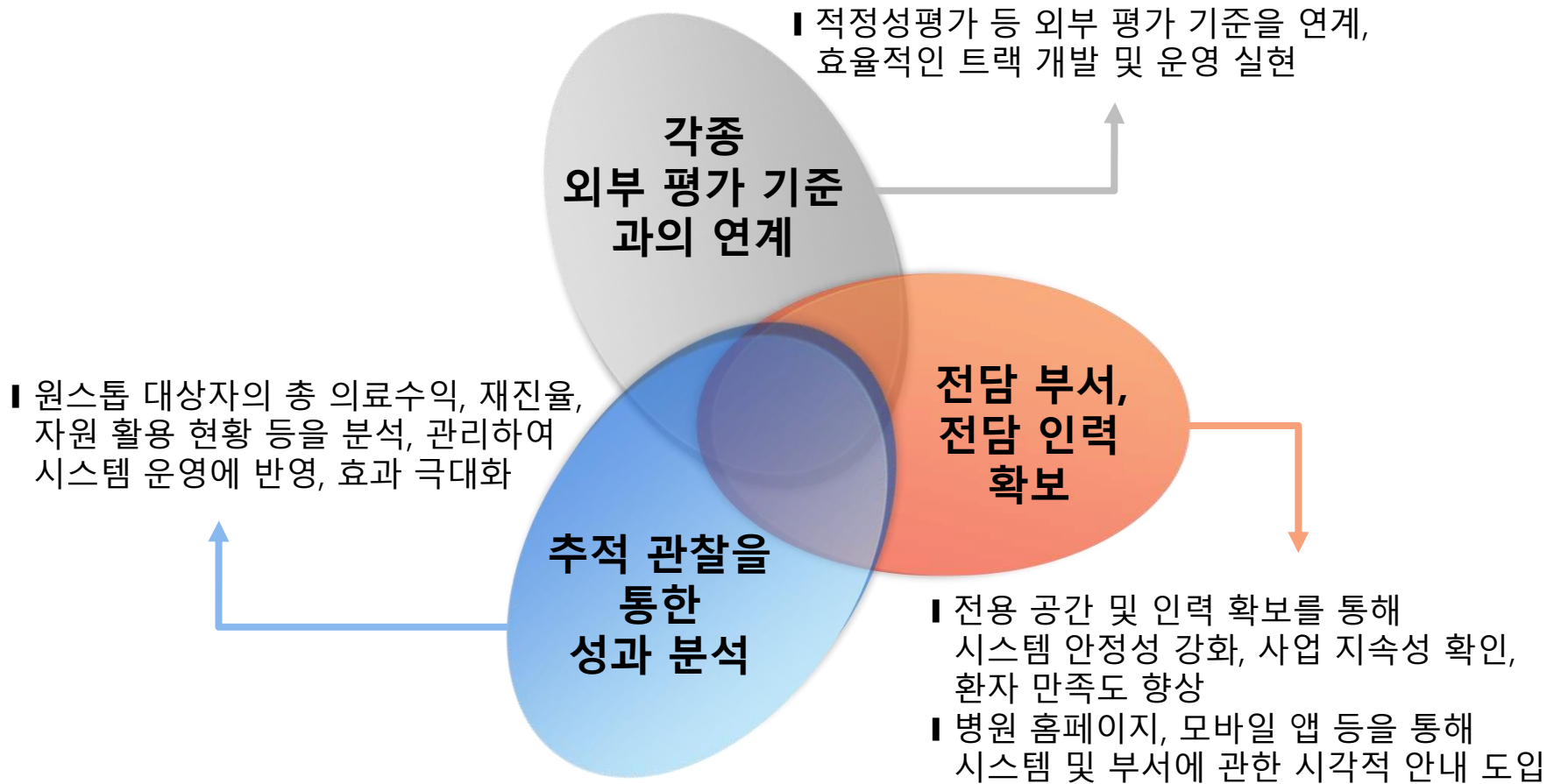
의료 질, 진료 효율성 향상

→ 병원 경쟁력 상승

- ✓ 원스톱 환자의 7일 이내 치료 개시
성공률 100% 달성을 통해
빠른 진단, 신속한 치료 실현
- ✓ 트랙 활성화에 따라 전원 의뢰 감소,
환자 이탈 이탈 방지
- ✓ 진료 유지율 증가, 수익 구조 강화
- ✓ 다직종, 다부서의 참여와 협조로
안정적인 시스템 정착
- ✓ 혜택을 받은 누적 환자 400명 돌파



확대 및 유지관리 방안



요약결과보고서

주제명	[CQI] 외래 원스톱 시스템 정착 및 활성화 활동
팀원	안세현, 최정인, 이정인, 이미정, 서정원, 이현중, 서현주, 정진혁, 김민정, 김주라, 조은별, 이지현, 정다운
활동의 필요성	2024년도 Top Down QI 활동을 통해 개발된 원스톱 시스템은 치료의 적시성을 높이고, 의료자원을 효율적으로 활용하기 위한 진료체계였다. 활동 결과 원스톱 시스템을 적용할 경우 일반 환자에 비해 대기일수가 크게 감소하여 직원, 환자 모두 긍정적인 반응을 보였다. 이에 다양한 장점을 확대하고자 시스템의 정착 및 활성화를 위해 추가 활동이 필요함을 제안하였으며, 시스템 운영을 위한 다양한 지원을 통해 원스톱 시스템의 활성화, 더 나아가서는 의료의 질을 향상시키고자 한다.
문제 분석 (현 수준)	전년도 QI활동 결과 재진 대기일은 활동 전 20.0일에서 원스톱 적용 환자의 경우 14.4일로 감소하였으며, 검사 대기일은 활동 전 32.4일에서 적용 후 3.0일로 대폭 감소하였다. 활동 종료 후 원스톱 시스템은 2024년 12월 31일까지 누적대상자 23명, 트랙 1개로 실질적인 효과 평가를 위해서는 확대 적용이 필요함을 확인하였다. 타원의 경우에도 이미 중증도와 시급성에 따라 일반 외래 환자와는 별도로 운영하는 빠른 진료 제도를 구축하고 활발하게 운영하고 있다. 그러나 본원에서는 2024년 Top Down QI활동을 통해 시스템 체계는 마련되었으나 아직 활성화하지는 못하고 있다.
핵심지표 및 목표	핵심지표는 '월 평균 적용 환자 수(명)'으로, 현 수준 4.4명에서 목표는 30명 이상으로 약 7배 이상 상승하도록 하였다. 수집기간은 2024년 8월 1일 ~ 2024년 12월 31일을 1차 조사 기간으로, 2025년 1월 1일 ~ 2025년 10월 31일을 2차 조사 기간으로 하였다. 자료는 EHR 원스톱 모니터링 시스템을 활용하였다.
개선활동	우선 원스톱 시스템을 활성화하기 위하여 트랙을 추가 개발하였다. 참여 진료과를 대상으로 뉴스레터를 발간하였으며, 부서 안내 표지판 및 배너 설치를 통해 시스템 홍보 효과를 도모하였다. 원스톱 시스템 전용 CAPA 확보를 통해 7일 이내 검사 진행의 확실성을 높였고, 참여 부서 정기 간담회, 참여 진료의 대상 설문조사 시행, 원스톱 시스템 개시 1주년 기념 이벤트 등을 통해 진료과 참여율을 높였다.
개선활동의 효과	활동 결과 핵심지표인 '월 평균 원스톱 트랙 적용 환자 수'는 4.4명에서 38.8명으로, 목표인 30명 이상을 달성하였다. 핵심지표 외에도 트랙 개수는 1개에서 6개로 증가하였고, 누적 적용 환자 수는 408명(2025년 10월 31일 기준)으로 400명을 돌파하였으며, 추세로 보아서는 2025년 내 500명 이상을 돌파할 것으로 예상된다. 원스톱 적용 성공률 또한 확장기 79.6%까지 감소하였으나, CAPA 확보 등을 통해 7월 이후로는 90% 이상을 유지하고 있으며, 특히 9월에는 성공률 100%를 달성하였다. 원스톱 적용 환자 대기일수 또한 평균 3.4일로 진료일로부터 예약제 검사 시행까지 3~4일이면 수행 가능함을 확인하였다. 직원 만족도 또한 4.2점/5점, 전반적인 환자 만족도 또한 4.7점/5점으로 매우 높았다. 특히 원스톱 시스템이 활성화된 이후, 해당 상병에 대한 타원으로의 의뢰서 작성 건수 및 비율 모두 감소하였으며, 원스톱을 적용한 이후에는 85.7%가 본원에서 치료를 지속하는 것을 확인하였다. 더불어 전산 추가 기능 개발을 통해 산정특례 정보 조회 등이 가능해지면서 이후 각종 평가 대상 환자를 위한 협업 가능성을 확보하였다.
결론 및 향후 관리방안	활동 결과 부서 협업을 통해 안정적으로 시스템이 정착하였고, 병원의 경쟁력이 강화되었으며, 의료의 적시성이 향상되었다. 그러나 아직 마련되지 않은 전담 부서 및 전담 인력 확충은 해결해야 할 과제로 남아 있다. 또 추적 관찰을 통한 성과 분석을 통해 각종 수익, 재진율, 자원 현황 등을 분석, 관리함으로써 시스템 운영에 반영하여 효과를 극대화하여야 한다. 더불어 각종 외부 평가 기준과의 연계를 통해 효율적인 트랙 개발 및 운영을 실현하는 것은 장기적으로 관리하여